Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Respiratório

Bronquiolite Viral Aguda

Do primeiro chiado à alta

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Bronquiolite viral aguda

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Menor de 2 anos com coriza que evolui com chiado e esforço: diagnóstico clínico, tratamento de suporte, oxigênio só para hipoxemia e nada de broncodilatador, corticoide ou antibiótico de rotina.

1. **Vírus:** VSR em até 80%; depois rinovírus. Sazonal de fevereiro a agosto.
2. **Curso:** pico no **3º–5º dia**; resolve em ~10 dias; tosse até 3–4 semanas.
3. **Gravidade (MS):** SatO2 > 92% leve; 90–92% moderada; < 90% grave. Um critério alto basta.
4. **Menor de 2 meses:** interna mesmo leve (MS). Menor de 6 semanas pode vir só com apneia.
5. **Exames:** nenhum de rotina. RX imita pneumonia e não decide antibiótico.
6. **Hidratação:** oral → sonda → veia isotônica. Nunca hipotônico: ADH alto.
7. **Suporte:** O2 1–3 L/min → alto fluxo 2 L/kg/min → CPAP 7–8 cmH2O → intubação.
8. **Prevenção:** vacina na gestante ≥ 28 sem; nirsevimabe dose única para prematuro ≤ 36s6d e comorbidades.

Não fazer

Intervenção	Veredito
Salbutamol, ipratrópio	Não
Adrenalina, corticoide	Não
Salina hipertônica	Não de rotina
Antibiótico	Só se bacteriana
Fisioterapia, aspiração profunda	Não de rotina

Pegadinha

O MS usa 92% como corte; NICE e a diretriz australasiana usam 90% a partir de 6 semanas, sem doença de base. Prova brasileira: MS.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço bronquiolite e seus diferenciais
- ☐ Classifico leve, moderada e grave
- ☐ Sei os critérios absolutos de internação
- ☐ Sei por que não pedir RX nem exames
- ☐ Escolho a via de hidratação e o soro
- ☐ Subo a escada de suporte respiratório
- ☐ Sei a lista do que não prescrever
- ☐ Dou alta com critérios e retorno em 48 h
- ☐ Sei quem recebe nirsevimabe e a dose